Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология 2

2.3 Локализация 2

2.4 Клиническая картина 3

2.5 Жалобы и анамнез 3

3. Диагностика 3

3.1 Лабораторные исследования 4

3.2 Дифференциальная диагностика 4

4. Лечение 4

4.1 Хирургическое лечение 4

4.2 Антибактериальная терапия 5

4.3 Дополнительная терапия 5

4.4 Послеоперационное ведение 6

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения 6

6. Источник и актуальность 6

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Лечение паратонзиллярного абсцесса осуществляет оториноларинголог в условиях стационара; основным методом лечения является хирургическое вскрытие абсцесса.
- В большинстве случаев (более 70%) абсцесс имеет передневерхнюю локализацию и располагается между капсулой нёбной миндалины и верхней частью передней нёбной дужки.
- Антибактериальные препараты широкого спектра действия, активные в отношении анаэробов, применяются эмпирически, до получения результатов посева; курс терапии, как правило, составляет 10–14 дней.
- При частых ангинах в анамнезе, повторном развитии или затяжном течении абсцесса, неадекватном дренировании и кровотечении после вскрытия нёбные миндалины удаляют одновременно со вскрытием абсцесса (абсцесстонзиллэктомия).
- Если выполнено только вскрытие абсцесса, двустороннюю тонзиллэктомию проводят в плановом порядке через 3 месяца.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс характеризуется гнойным расплавлением паратонзиллярной клетчатки, расположенной между псевдокапсулой нёбной миндалины и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Этиология

В большинстве случаев абсцесс развивается как осложнение ангины, несколько реже на фоне хронического тонзиллита. Возможен также одонтогенный путь инфицирования при кариесе задних зубов нижней челюсти (вторых моляров, зубов мудрости) и периостите альвеолярного отростка, а также инфицирование при попадании в паратонзиллярную клетчатку инородного тела (например, рыбной кости).

Наиболее частыми возбудителями являются бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробные микроорганизмы.

На момент обращения отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная форма выявляется у 15–20% пациентов, абсцедирующая форма у 80–85%. Абсцесс формируется, как правило, через 4–6 дней от начала заболевания, в ряде случаев в течение нескольких часов.

2.3 Локализация

Передневерхний (супратонзиллярный) абсцесс встречается более чем в 70% случаев и располагается между капсулой миндалины и верхней частью передней нёбной дужки. Задний абсцесс (около 15% случаев) располагается между миндалиной и задней нёбной дужкой, нижний (несколько более 5%) между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки, боковой (менее 5%) между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс, как правило, развивается на фоне ангины или через несколько дней после её завершения. Заболевание начинается с боли при глотании, которая становится постоянной, резко усиливается при попытке проглотить слюну и иррадиирует в ухо и зубы. Пациентов беспокоят головная боль, общая разбитость, отмечается повышение температуры тела до фебрильных значений, пациенты отказываются от пищи и питья. В подавляющем большинстве случаев постепенно нарастает тризм жевательной мускулатуры, речь становится невнятной и гнусавой. Вследствие болезненности при поворотах головы пациент держит голову набок и поворачивается всем корпусом.

При передневерхнем абсцессе отмечается резкое выбухание верхнего полюса миндалины вместе с нёбными дужками и мягким нёбом к средней линии, язычок смещён в противоположную сторону, миндалина оттеснена книзу и кзади.

При заднем абсцессе припухлость определяется в области задней нёбной дужки, процесс может распространяться на боковую стенку глотки; миндалина и передняя дужка изменены незначительно, язычок и мягкое нёбо отёчны.

При нижнем абсцессе при фарингоскопии определяются лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки, несмотря на выраженные жалобы. В процесс может вовлекаться корень языка, в ряде случаев развивается отёк язычной поверхности надгортанника; распространение отёка на гортань может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс встречается реже остальных форм, однако характеризуется наиболее тяжёлым течением, поскольку условия для самопроизвольного прорыва гноя в полость глотки наименее благоприятны. Выражены отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения, кривошея, тризм; при фарингоскопии определяется лишь умеренное выбухание всей миндалины.

2.5 Жалобы и анамнез

При сборе анамнеза следует уточнить наличие недавно перенесённых ангин, хронического тонзиллита, паратонзиллитов и абсцессов в прошлом и проводившегося лечения, кариеса, возможного попадания инородного тела (например, рыбной кости).

Пациенты предъявляют жалобы на выраженную, как правило одностороннюю боль в горле, усиливающуюся при глотании и иррадиирующую в ухо и зубы, ощущение инородного тела, гнусавость, неприятный запах изо рта, боль в шее при поворотах головы, тризм, слюнотечение. Из общих жалоб отмечаются слабость, разбитость, фебрильная лихорадка, головная боль; эти жалобы неспецифичны и требуют проведения дифференциальной диагностики.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, физикального обследования с тщательной оценкой подчелюстной области и регионарных лимфатических узлов, данных фарингоскопии и лабораторных исследований.

Каждого пациента с подозрением на паратонзиллярный абсцесс осматривает врач-оториноларинголог.

Местные признаки наиболее выражены при переднем абсцессе: яркая гиперемия, отёк и инфильтрация нёбных дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка, асимметрия мягкого нёба, смещение миндалины, ограничение открывания рта, регионарный лимфаденит.

Фарингоскопию выполняют всем детям и взрослым; её данные имеют решающее значение для постановки диагноза.

При подозрении на распространение воспалительного процесса на гортаноглотку показана непрямая ларингоскопия или фиброларингоскопия.

Компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) шеи применяют в тяжёлых случаях, когда требуется уточнить диагноз и локализацию абсцесса или провести дифференциальную диагностику с воспалением глубоких отделов шеи.

3.1 Лабораторные исследования

Всем пациентам выполняют развёрнутый общий анализ крови, исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) и общий анализ мочи. Выраженный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и высокий уровень СРБ свидетельствуют о высоком риске осложнений и требуют коррекции лечения, в том числе антибактериальной терапии.

Гнойное отделяемое, полученное после вскрытия абсцесса, направляется на посев на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам; мазок с миндалин исследуется на палочку дифтерии для исключения дифтерии.

Для исследования предпочтительно брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости, поскольку ферменты гноя разрушают микроорганизмы. Материал доставляется в лабораторию в транспортной среде, оптимально в течение 40 минут.

3.2 Дифференциальная диагностика

Паратонзиллярный абсцесс дифференцируют с дифтерией, скарлатиной, абсцессом язычной миндалины, абсцессами подъязычной области, флегмоной дна полости рта, опухолями ротоглотки и перикоронитом.

При дифтерии слизистая оболочка бледная, с цианотичным оттенком, налёты сероватые, распространяются за пределы миндалин, тризм отсутствует.

Для скарлатины характерны сыпь на коже, чёткая граница поражённой слизистой оболочки, «малиновый» язык. При абсцессе язычной миндалины тризм и типичные изменения в ротоглотке отсутствуют. При флегмоне дна полости рта отмечаются боль и отёк в подчелюстной области, язык малоподвижен, нёбные дужки и миндалины не изменены.

Опухоли миндалины характеризуются медленным развитием, отсутствием лихорадки, выраженного болевого синдрома и тризма; регионарные лимфатические узлы плотные, малоболезненные, малоподвижные.

В редких случаях припухлость в глотке обусловлена близким к поверхности расположением сонной артерии или её аневризмой; на это указывает визуально определяемая пульсация.

4. Лечение

Лечение осуществляет оториноларинголог в специализированном учреждении; основным методом лечения является хирургическая санация полости абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

При впервые возникшем абсцессе показаны его вскрытие и дренирование.

Независимо от техники вскрытия необходимо убедиться в отсутствии пульсации в месте разреза, глубже 0,5 см продвигаться только тупым путём, разрез выполнять достаточно широким, до 4 см.

Место разреза определяется локализацией абсцесса; операцию выполняют под местной аппликационной анестезией. Передневерхний абсцесс вскрывается через переднюю нёбную дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания, задний абсцесс через заднюю дужку с отступом 0,5 см от её края, нижний абсцесс в нижней части передней дужки. Ткани рассекаются вдоль хода сосудов на глубину 0,5–1 см, далее разводятся корнцангом.

В последующем края разреза регулярно разводятся до начала заживления полости.

При частых ангинах в анамнезе, повторном развитии паратонзиллита или абсцесса, затяжном течении, неадекватном дренировании и кровотечении после вскрытия показано удаление нёбных миндалин одновременно со вскрытием абсцесса, что позволяет устранить и сам очаг инфекции.

Операция выполняется в любом возрасте, от 3–4 до 70 лет и старше. Противопоказаниями являются терминальное или крайне тяжёлое состояние, обусловленное заболеваниями внутренних органов, тромбоз сосудов мозга, разлитой менингит.

После операции осматривают тонзиллярную нишу; выбухание в ней свидетельствует о парафарингеальном абсцессе.

4.2 Антибактериальная терапия

Системную антибактериальную терапию начинают эмпирически, не дожидаясь результатов посева. Поскольку в полости абсцесса, как правило, присутствуют анаэробы, необходимы препараты широкого спектра действия, активные и в отношении анаэробной микрофлоры.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	С 12 лет или при массе тела от 40 кг — 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. Возможно применение #амоксициллина с сульбактамом по 1 г 2–3 раза в сутки с 12 лет, до 10 дней. Детям до 12 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Цефтриаксон	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки; длительность в таблице рекомендации указана как «в течение 4–14 дней до 10 дней». Новорождённым до 2 недель — 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не более 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки.
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки, до 10 дней. Новорождённым и детям до 12 лет — 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; недоношенным — не более 50 мг/кг в сутки.
Клиндамицин	300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении — до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма. Детям при непереносимости цефалоспоринов III поколения — #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

Курс антибактериальной терапии, как правило, составляет 10–14 дней. Препаратами выбора являются пенициллины, в том числе в сочетании с ингибиторами бета-лактамаз. При затруднённом глотании применяются диспергируемые формы, суспензии или инъекционные формы. При выраженном отёке тканей глотки и шеи, выраженном тризме и высоком риске генерализации инфекции применяют парентеральные цефалоспорины III поколения, а при их непереносимости клиндамицин. Детям предпочтительно назначение ампициллина с сульбактамом и амоксициллина с клавулановой кислотой.

4.3 Дополнительная терапия

При выраженных воспалительных проявлениях используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в стандартных дозах.

Всем пациентам рекомендованы антигистаминные препараты системного действия.

Рекомендацией предусмотрено также применение средств, повышающих естественную резистентность организма (препараты кальция, витамины С и А); при этом следует избегать полипрагмазии.

При выраженной интоксикации необходима инфузионная дезинтоксикационная терапия.

Всем пациентам рекомендованы также местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства (полоскания, инсуффляции, ингаляции, таблетки для рассасывания), однако они не заменяют системную антибактериальную терапию.

После хирургического лечения, не ранее чем через 3 недели после купирования острого воспаления, показана консультация физиотерапевта.

4.4 Послеоперационное ведение

После вскрытия абсцесса двусторонняя тонзиллэктомия выполняется в плановом порядке через 3 месяца.

После тонзиллэктомии в течение месяца рекомендуется ограничение физической нагрузки.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения

При диспансеризации выявляют факторы риска (хронический тонзиллит, рецидивирующие ангины); профилактика включает закаливание и своевременное лечение заболеваний зубов и дёсен.

Лечение осуществляется в хирургическом стационаре. Показанием к госпитализации является необходимость вскрытия абсцесса или удаления нёбных миндалин со вскрытием абсцесса. После вскрытия улучшение состояния отмечается уже через 12–24 часа. При неосложнённом течении после абсцесстонзиллэктомии пациент выписывается на 5–7-е сутки.

При отсутствии лечения или неадекватном лечении высок риск гнойных осложнений: флегмоны шеи, медиастинита, тонзиллогенного сепсиса, инфекционно-токсического шока. Риск возрастает у пациентов с иммунодефицитом (врождённым, на фоне приёма иммуносупрессоров и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции).

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефтриаксона в таблице 1 указано «в течение 4-14 дней до 10 дней», что содержит противоречие в сроках; на странице формулировка приведена дословно.
- Знак # у амоксициллина с сульбактамом и у детской дозы клиндамицина обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.